

Dolor Crónico

ACT — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

El dolor crónico se define como dolor persistente por más de 3 meses, que frecuentemente no responde a tratamiento médico y está asociado a deterioro funcional, depresión y ansiedad. ACT conceptualiza el problema central no como el dolor en sí, sino como la **lucha contra el dolor** y la **inflexibilidad psicológica** que reduce la calidad de vida. La evidencia de ACT en dolor crónico es una de las más sólidas del campo.

MARCO ACT PARA EL DOLOR CRÓNICO

El objetivo no es reducir el dolor sino aumentar la **flexibilidad psicológica**: la capacidad de moverse hacia lo que importa incluso con dolor presente. El cambio del foco — de controlar el dolor a vivir una vida valiosa — es central.

INTERVENCIONES ACT — PASO A PASO

1	Psicoeducación: la trampa del control Explorar qué ha intentado el paciente para eliminar el dolor y cuánto ha costado (actividades abandonadas, vida reducida).
2	Desesperanza creativa No para desanimar, sino para abrir un espacio nuevo. Preguntar: '¿la lucha contra el dolor le ha dado la vida que quiere?' Facilitar el contacto con el costo real de la agenda de control.
3	Defusión de pensamientos sobre el dolor Trabajar pensamientos fusionados: 'nunca voy a mejorar', 'no puedo hacer nada con este dolor'. Técnica: nominar los pensamientos como pensamientos ('estoy notando el pensamiento de que...'). Metáfora del pasajero del autobús.
4	Aceptación del dolor como experiencia Distinguir dolor (sensación) de sufrimiento (lucha contra el dolor). Ejercicios: observar el dolor con curiosidad, sin intentar reducirlo ni amplificarlo. Mindfulness de sensaciones corporales.
5	Clarificación de valores ¿Qué importa para este paciente más allá del dolor? Trabajo con áreas vitales: familia, trabajo, salud, relaciones, ocio. Identificar qué ha abandonado por el dolor y si eso está alineado con sus valores.
6	Acción comprometida graduada Establecer objetivos de acción vinculados a valores, comenzando por pasos pequeños. El dolor puede estar presente — el objetivo no es esperar a no tener dolor para vivir. Construir compromisos concretos y evaluar barreras.
7	Trabajo con el yo-contexto Ejercicios de perspectiva del observador: el yo que observa el dolor no es el dolor. Especialmente útil en pacientes que se identifican completamente con su condición ('soy un enfermo crónico').

Dolor Crónico

ACT — Ficha clínica

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	Foco en rol laboral y vida relacional limitada por el dolor. Coordinar con médico tratante. Psicoeducación sobre neurociencia del dolor puede ser útil antes de la intervención ACT.
Adultos mayores	Mayor prevalencia de condiciones crónicas. Énfasis en valores de relación, legado y presencia. Adaptar ejercicios físicos de mindfulness a la capacidad del paciente.
Adolescentes	Dolor crónico en adolescentes frecuentemente vinculado a migrañas, dolor abdominal o fibromialgia. Impacto en asistencia escolar y relaciones. Trabajar valores en contexto de desarrollo identitario.

Clave clínica: El terapeuta no debe tener el objetivo de reducir el dolor — eso reproduce la agenda del control. El objetivo es ampliar la vida. El dolor puede mejorar como resultado, pero no como meta directa.